PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Tendinopatia do Aquiles

Manejo de carga como tratamento, em seis passos

Lesões: Mecanismos, Epidemiologia e Prevenção

CASO ILUSTRATIVO

Homem na casa dos quarenta, corredor há anos. Entraram ladeira e tiro.

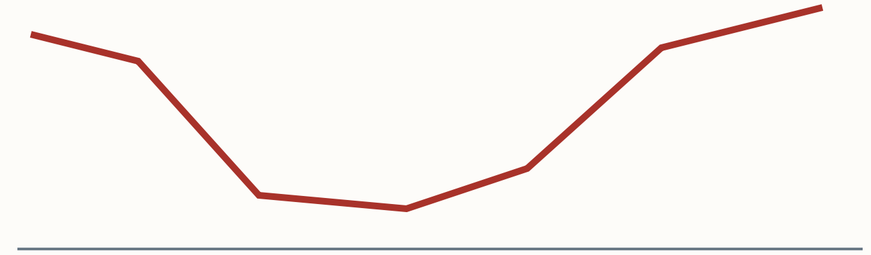
casa dos quarenta, corre há anos, três vezes por semana

antes	corrida	corrida	corrida
depois	corrida	ladeira	tiro

volume quase igual · o estímulo mudou todo

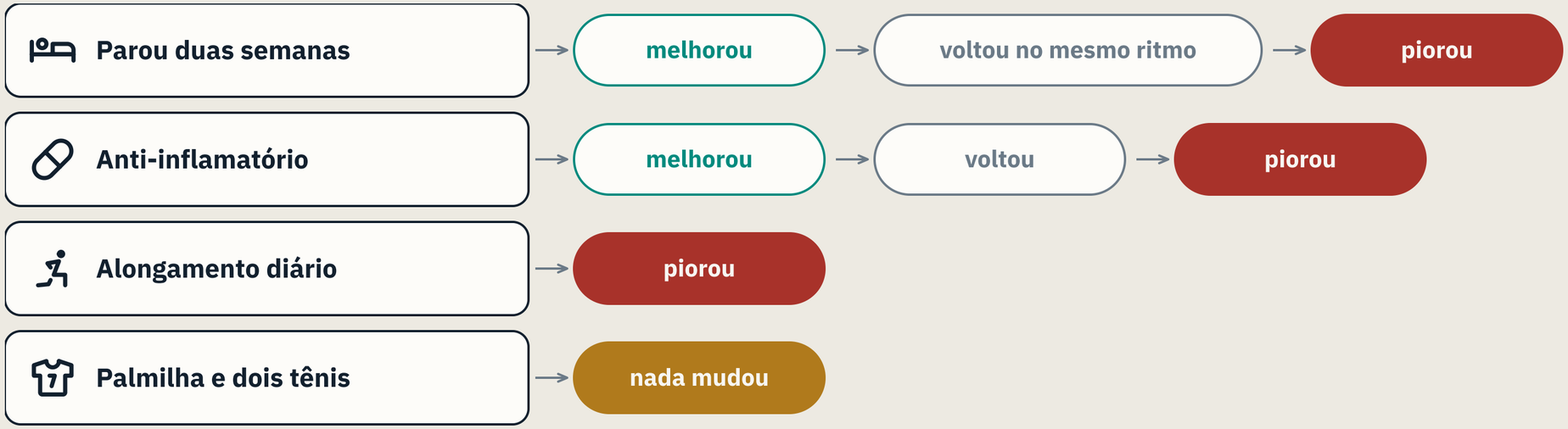
semanas depois: dor no Aquiles

dor · esquema



O CICLO DE SEMPRE

“Já tentei de tudo e nada funciona”



> Faltou a única coisa com boa evidência: carga bem dosada, por tempo suficiente.

Três perguntas antes de prescrever

1 O que mudou?

- volume
- ladeira
- tiro
- salto
- pausa
- piso
- calçado
- horário

2 Há compressão?

- piora em alongamento máximo
- piora em escada
- piora em agachamento fundo

3 E a manhã seguinte?

primeira pisada

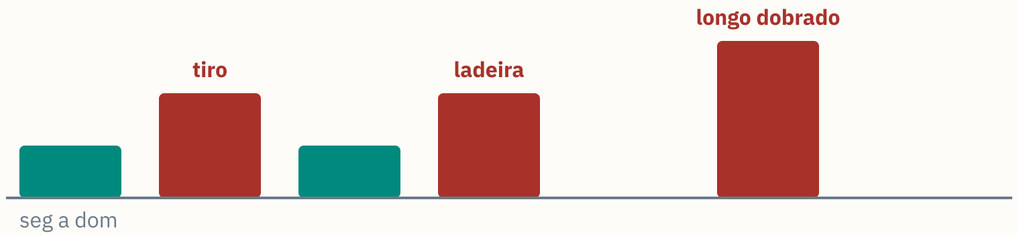
rigidez e primeira pisada: o termômetro do dia anterior

> No caso ilustrativo, a resposta era evidente: entraram os estímulos que mais pedem do tendão como mola.

PASSO DOIS · AJUSTAR SEM ZERAR

Tirar os picos, manter o resto

Sai por algumas semanas



- tiro, ladeira, salto
- mudança brusca de ritmo
- posições de compressão
- a sessão longa que é o dobro

Fica



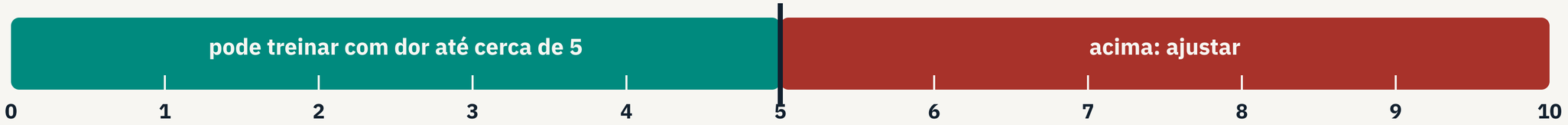
- corrida confortável em piso plano
- volume dentro da régua de dor
- **a força, que é o tratamento**

esquema

> Quem chegou esperando ouvir “pare de correr” e ouve “corra de outro jeito” adere muito mais.

PASSO TRÊS · A RÉGUA DA DOR

Até cerca de 5 em 10, com três condições



Volta ao basal na manhã seguinte

a primeira pisada é o termômetro

Não sobe de semana para semana

a tendência importa mais que o dia

A função não piora

continua conseguindo fazer o que fazia

> Em 38 pacientes, continuar correndo e saltando com a régua deu o mesmo resultado que o repouso ativo.

Silbernagel e colegas, Am J Sports Med 2007

A dose do ensaio dinamarquês, no Aquiles

a carga sobe a cada degrau: as repetições máximas caem

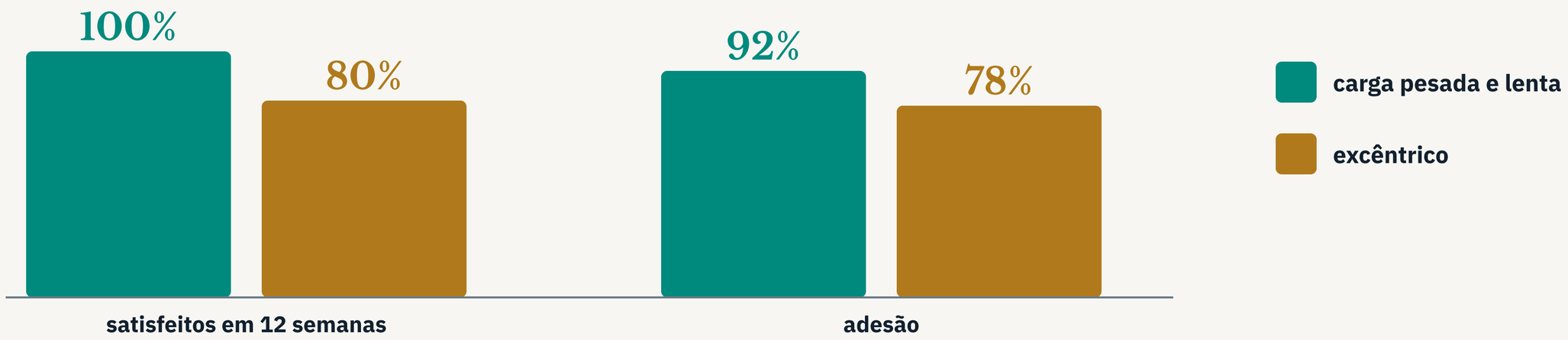


Três vezes por semana, 3 s para subir e 3 s para descer. Antes, se a dor estiver irritada, isometria: 5 × 45 s.

Am J Sports Med 2015 · isometria: Br J Sports Med 2015

CARGA PESADA E LENTA CONTRA EXCÊNTRICO, 58 PESSOAS

Os dois funcionam; um se cumpre melhor



> A diferença de satisfação sumiu em um ano. Carga suficiente, consistente, por tempo suficiente, importa mais que a escola.

Am J Sports Med 2015

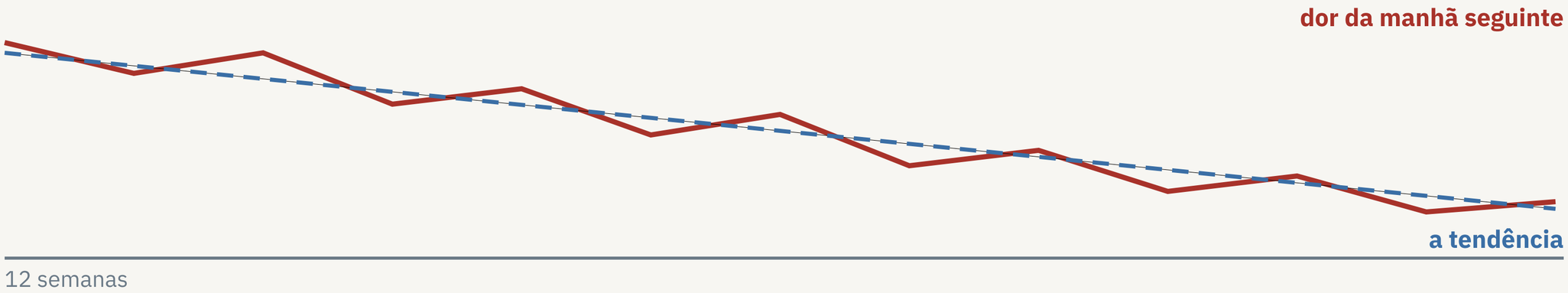
AS FASES QUE COSTUMAM SER PULADAS

Progride quem passa no critério



A fase da mola é a mais pulada e é a que prepara para o esporte. Critério: manhã seguinte estável, força subindo, novo estímulo tolerado.

Doze semanas, com oscilação



> Meça algo e mostre, reavalie a cada duas ou três semanas, avise que vai oscilar. Semana ruim não é estaca zero.

Esquema, sem valores medidos

PASSO SEIS · POR QUE FALHA

Quase nunca é o tratamento

Dose baixa

se conversa tranquilo na série, não está pesado

Tempo curto

quatro semanas é amostra grátis

Causa intacta

a ladeira continua igual

Sem fase de mola

alta, tiro no fim de semana, dor de volta

Imagem como régua

compare função, não estrutura

Bem feito e não melhora

rever o diagnóstico com o médico

O plano, não o desfecho

1 Primeiras semanas

corrida leve em plano; sem ladeira, tiro e alongamento sustentado; isometria se irritado

manhã seguinte estável

2 Força

carga pesada e lenta, 3 × por semana, registrada

força subindo, régua mantida

3 Mola

salto em volume baixo

régua mantida

4 Esporte

tiro 1 × por semana, depois ladeira

uma novidade de cada vez

> Depois da alta, força duas vezes por semana como hábito: é o que mais protege contra a recaída.

SEIS PASSOS

Carga bem dosada, por tempo suficiente

- Entender a carga que causou; ajustar sem zerar
- Régua da manhã seguinte; fases até a mola e o esporte
- Prazo dito em voz alta no primeiro dia

Médico

Diagnostica e descarta o que imita tendinopatia.

Fisioterapia

Prescreve, progride e reavalia o exercício.

Preparação física

Ajusta o treino e mantém a força como hábito.

Próxima aula: o joelho, dois problemas debaixo da mesma queixa.